

Información Paciente

Nombre : Luis Alberto Barra Toledo
Edad : 49a 8m 3d
Dirección : Cerro El Corazon 1985 Valle Alto

Rut : 12.733.491-9
Fecha Nacto: 09/12/1974
Comuna : Pirque

N° Archivo : 9837651
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 7905 3643

N° Epicrisis
407404

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Ingreso : 18/07/2024 18:14

Días Estadía: 25

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 12/08/2024 11:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Aumento de volumen facial

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR/UTIM: 18/07/2024
FI UCI: 11/08/2024

Antecedentes

- Médicos: Ninguno hasta hospitalización que se describe a continuación.
- Quirúrgicos: Apendicectomía.
- Fármacos: Metadona 5 mg cada 8 h VO, morfina 8 gotas SOS, omeprazol 20 mg, PEG 17 g cada 8 h, prednisona 40 mg/día, cotrimoxazol trisemanal, fluconazol 150 mg trisemanal.
- Alergias: Ninguna.
- Hábitos: TBQ (-), OH (-), drogas (-)
- Hospitalizaciones: 06 - 20/05/2024 en Hemato-oncología por sospecha de linfoma T/NK nasal.
- Funcionalidad: ECOG 1.

Resumen de historia previa:

Paciente en seguimiento desde diciembre de 2023, en ese entonces con historia de al menos 10 meses manejado como sinusitis que no respondió a cursos de antibióticos, progresando con úlcera palatina indolora, que al estudio con TC evidencia ocupación de ambas fosas nasales y senos maxilares con destrucción ósea del paladar duro. En ese contexto inicia estudio histológico, entre otros.

- Biopsia de úlcera palatina 14/12/2023: Proceso inflamatorio crónico granulomatoso, con PAS (-), Grocott (-) y Ziehl neelsen (-).

- 23/01/2024: Antrostomía maxilar bilateral con biopsias diferidas y CMF: Informa proliferación linfoide atípica en la mucosa nasal. CMF sin elementos de clonalidad. El informe complementario es sugerente de vasculitis.

- Biopsia de fosa nasal izquierda 12/02/2024: Granuloma telangiectásico.

- PET/CT mayo 2024: No logro rescatarlo, se describe en epicrisis masa hipermetabólica palatina y gingivo-dentaria, fistulizada a fosas nasales, asociada a presencia de engrosamiento dermoepidérmico nasal hipermetabólico y pequeñas adenopatías levemente hipermetabólicas yugulares bilaterales, compatibles con compromiso por síndrome linfoproliferativo, además informa foco hipercaptante en colon sigmoideas.

- Otros: FR (-), complemento normal, ANCA por IFI (-), ANA (-).

Se hospitaliza en hemato-oncología para estudio, donde se evalúa el caso con anatomía patológica e impresiona poco probable un linfoma NK nasal, por lo que se realizan nuevas biopsias.

Fecha Epicrisis : 12/08/2024 11:22

Fecha Última Actualización: 12-08-2024 11:22:28

Página 2 de 3

- Biopsia punch por dermatología 08/05: No apoya el diagnóstico de síndrome linfoproliferativo, podría encontrarse en el contexto de una vasculitis.

- Muestras por ORL 17/05: PCR para hongos (-), PCR para bacterias (-), Xpert en tejido (-)

Al alta con sospecha de granulomatosis (causa en estudio) vs linfoma NK.

Historia de ingreso

Tras extenso estudio descrito, paciente acude a Instituto del cáncer 20/06 donde se definió inicio de prednisona 40 mg/día por sospecha de vasculitis GPA, con importante mejoría sintomática, destacando mejoría en su deglución y en dolor local, suspendiendo rescates de morfina, además desaparece aumento de volumen maxilar izquierdo. En control con patología oral 27/06 se agregó curso de fluconazol 150 mg/día por medio. El día previo al ingreso acude a control con reumatología, donde se define hospitalización por cuadro de 7 días de aumento progresivo de volumen en hemicara derecha, asociado a reaparición de placas de pus en úlcera palatina, con disfagia severa, diaforesis y disnea ocasional, sin fiebre, estridor ni otros síntomas.

Diagnósticos de ingreso:

1. Masa palatina en estudio:

- Linfoma NK vs vasculitis

2. Obs flegmón/absceso facial derecho

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN

1. HDN: autosostenida, no es conflicto.

2. Respiratorio: masa de paladar duro y blando, refiere disnea leve al ingreso, sin estridor, sin requerimientos de O2 ni apremio ventilatorio. Se realiza traqueostomía el 02.08.24

3. Reumatológico/Hemato-oncológico: antecedentes descritos en ingreso, estudio extenso por cuadro de úlcera palatina con extensión a maxilares bilaterales, con múltiples biopsias incisionales y por punción. En suma: biopsias muestran linfocitos atípicos y granulomas, compatibles con vasculitis; PET con masa maxilar hipercaptante con fistulización a fosas nasales y adenopatías cervicales, sugerente de SLP; CMF en tejido sin clonalidad, reordenamiento policlonal en PCR gen TCR gamma y gen IgH; PCR de bacterias, hongos y TBC negativa. Evaluado ya por reumatología y hematología, les impresiona poco probable linfoma NK, siendo más probable vasculitis GPA; sin embargo, cuenta con VHS 15 (antes de corticoides), ANA, ANCA IFI, MPO y PR3 (-), sin compromiso renal o pulmonar. Actualmente hospitalizado por aumento de volumen facial derecho obs sobreinfectado, se realiza TAC de cabeza y cuello + TAP, el cual descarta absceso/flegmón, informando alteración inflamatoria extensa de la mucosa del paladar duro y blando con compromiso de seno maxilar, compatible con vasculitis GPA, además de adenopatías cervicales de hasta 20 mm, que no permiten descartar linfoma. Evaluado por cirugía oncológica, se decide biopsia de adenopatía cervical para CMF. Se mantenía con prednisona en domicilio, se ajusta a hidrocortisona a dosis equivalentes para evitar uso de vía oral.

4. Infeccioso: aumento de volumen facial derecho de 1 semana de evolución, con cambios inflamatorios locales y exudado palatino purulento, se inició tazonam + vancomicina empírico. Febril, se tomaron hemocultivos (19/07) que resultan negativos. Evolucionó afebril, con parámetros inflamatorios en descenso, TAC sin complicación infecciosa. Se completa curso de 7 días de ATB.

5. Nutricional: Paciente refiere haber bajado más de 30 kg desde noviembre 2023 a julio 2024 (previamente pesaba 94 kg), producto de disfagia alta. Actualmente sólo con ingesta de líquidos y papilla, evaluado por ANI, con indicación de nutrición parenteral. Se instala PICC, inicio de parenteral el 26/07.

6. CCPP: usuario de metadona en domicilio (5 mg c/8 hrs), en plan de decalaje progresivo. Se disminuye dosis 20%, titular según evolución. Además se solicitó evaluación por psicología dado ánimo depresivo, realizan intervención, se inicia quetiapina PM para mejorar sueño.

7. Hematología: cursa con pancitopenia durante hospitalización, ausente en hospitalizaciones previas. Hemograma formal sin alteraciones significativas al frotis.

8. Profilaxis: Tromboprofilaxis con HBPM. Profilaxis con cotrimoxazol forte trisemanal por uso crónico de corticoides. Además estaba con fluconazol profiláctico, sin clara indicación, se suspende.

Fecha Epicrisis : 12/08/2024 11:22

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:20

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 12-08-2024 11:22:28

Página 3 de 3

El 11/08 en la madrugada presenta deterioro ventilatorio, TAC de Torax con extensa neumonia multifocal y lesiones hipodensas hepaticas incontables. Reinicia Imipenem/Vancomicina y se conecta a BPAP por TQT, sin mayor respuesta, por lo que se inicia sedoanalgesia para SAS 2 y se conecta a VMI. Se traslada a UPC para continuar manejo.

Ingresa a UCI en muy malas condiciones generales, con doble vasoactivo (NAD + adrenalina), conectado a VMI, SAS 1. Se inicia reanimacion energetica, se conecta a HDVVC con nula respuesta. Progresa rapidamente a falla organica multiple dado por fallas: hematologica, circulatoria, hepatica, renal, ventilatoria. Evolucion torpidamente llegando a shock refractario a pesar de todas las medidas de soporte entregadas. Llega al deceso el 12.08.24 a las 10:35 h. Se firma certificado de defuncion y se entrega a tutora (hija).

Diagnóstico de Egreso

SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA DE ORIGEN INFECCIOSO, CON FALLA ORGÁNICA - .
Tumor palatino/sental

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece a las 10:35 h del día 12.08.2024

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO



Bec. Diego Antonio Bec Olivares F
Becado/Residente



Andreina López Zamora
Médico Tratante (Staff)